

JOSI MARIA DA SILVA MACHADO			
MEDICAMENTOS:			
SINTOMAS/QUEIXAS			
BANHEIRO			
HORA QUE ACORDA			
HORA QUE DORME		não está indo ao banheiro.	
PRÁTICA EXERCÍCIO			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
25	P: 11.4 cmH ₂ O	relata ↓ da PA.	
07	IAH: 1.5 l/h		
22	M. de uso: 1h 50'		
	Bem adaptada	fua	
18/08	P: 10.7 cmH ₂ O	Fuga = 13.3 l/min.	
22	IAH: 2.0		
	M. de uso: 6h 40'		
	- Relata melhora do quadro de fadiga	fua.	
	- HAS normalizou		
16/10	P: 10.8 cmH ₂ O		
22	IAH: 3.0 l/h		
	M. de uso: 6h 30'		
	Bem adaptado / troca a masc.	fua	
	P: 8.8 cmH ₂ O med. / Perc. 95% = 10.8 cmH ₂ O		
	IAH: 7.5 l/h	- ajuste masc.	
	M. de uso: 6h 12'	- troca o filtro fua	
13/05/25	P: 9.9 cmH ₂ O (percentil)		
	IAH: 5.7 l/h	Troca fixador	
	M. de uso: 4h 24'	Troca filtro	
	fuga: 18.3 l/min	ajusta pressão	
	P: 8.10 cmH ₂ O	Natasha	
14/07	P: 10 cmH ₂ O	(↑ P inicial = 6)	
25	IAH: 8.1 (7.5 AO / 0.5 AC)	(8-12 cmH ₂ O)	
	M. de uso: 7h 23'	Retirei alívio fua.	
	fuga = 16.7		



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificado em Medicina do Sono
Coordenador Prossim de Sono
Mestrado em Psiquiatria pela UFRJ
Cirurgião em Psiquiatria pela UNIFESP
CRM-SP: 69.730

DRA. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Medicina do Sono
Cirurgias e Adolescente
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

for
NOME: Josefina Maria da Silva Machado
EXAME nº: 5152
SOLICITADO POR: Dra. Carolina Ruston Daher
DATA: 15/06/2022
IDADE: 61 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h08min e concluído às 06h00min. A latência para o sono foi de 11 minutos e a latência para o sono REM, de 187 minutos. O tempo total de sono foi de 483,5 minutos (08h03min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 91,1%. A distribuição do sono mostrou 15,1% de estágio 1, 42,7% de estágio 2, 24% de estágio 3 e 18,2% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 36,5 minutos em vigília, ocorreram 259 microdespertares (índice: 32,1/hora). *até 10/24*

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 9,8/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 88,7/hora, sendo 40,1 apneia/hora e 48,7 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 88,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 90% e a mínima de 72%.

*Normal
até 5/h*

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (88,7/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (88,7/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM e no decúbito dorsal, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 62; máxima: 93 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.
Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente dormiu no tempo esperado (latência para o sono: 11 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (187 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (91,1%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 32,1/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (15,1%; normal: 8-10%) e 3 (24%; normal: 10-12%), e a redução dos estágios 2 (42,7%; normal: 45-55%) e REM (18,2%; normal: 20%).

O índice de movimentos periódicos de membros permaneceu no limite da normalidade (9,8/hora; índice normal até 15/hora). Observei também movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 8 (normal até 9; máxima: 24).

*Dr. Alberto Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP: 69.730*

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP: 69.730